



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е. В. Ушаков

БИОЭТИКА

УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВУЗОВ

*Рекомендовано Учебно–методическим отделом высшего образования
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям*

**Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru**

Москва ■ Юрайт ■ 2016

УДК 614.253(075.8)

ББК 87.75я73

У93

Автор:

Ушаков Евгений Владимирович — кандидат философских наук, доцент кафедры истории и политологии факультета государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Рецензенты:

Винокур В. А. — доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Северо-Западного медицинского университета имени И. И. Мечникова;

Голик Н. В. — доктор философских наук, профессор кафедры культурологии, философии культуры и эстетики Санкт-Петербургского государственного университета.

Ушаков, Е. В.

У93

Биоэтика : учебник и практикум для вузов / Е. В. Ушаков. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 306 с. — Серия : Специалист.

ISBN 978-5-9916-6142-3

Современная медицинская наука и практика все более усложняется. Научные открытия, высокие технологии, практические инновации постоянно вносят изменения в систему здравоохранения. Однако это сопровождается ростом острых моральных проблем. Биоэтика — это поле не прекращающихся дискуссий, этического анализа, практической деятельности по защите важнейших ценностей общества в контексте современной медицины.

Учебник посвящен основам биоэтики как нового междисциплинарного направления. В нем отражены ключевые проблемы теоретических основ и практических приложений биоэтического знания. Задания и кейсы, входящие в практикум, помогут лучше разобраться в особенностях биоэтики и применить полученные знания на практике.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов медицинских вузов и средних учебных заведений, преподавателей, практикующих врачей и медицинских сестер, организаторов здравоохранения, а также всех, кто интересуется этическими проблемами современной медицины.

УДК 614.253(075.8)

ББК 87.75я73



Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

ISBN 978-5-9916-6142-3

© Ушаков Е. В., 2015

© ООО «Издательство Юрайт», 2016

Оглавление

Предисловие	5
Глава 1. История и теоретические основы биоэтики.....	7
1.1. История развития медицинской этики и биоэтики.....	7
1.2. Предметная сфера биоэтики.....	14
1.3. Теоретические основы современной биоэтики.....	21
1.4. Жизнь как ценность: проблемы качества жизни в биоэтике.....	33
1.5. Основные принципы и правила биомедицинской этики	40
<i>Практикум</i>	<i>48</i>
Глава 2. Врач и пациент: этические аспекты взаимоотношений	53
2.1. Основные моральные модели взаимоотношений врача и пациента.....	53
2.2. Права пациента.....	59
2.3. Права и обязанности врачей	67
2.4. Этика медицинской сестры	75
<i>Практикум</i>	<i>83</i>
Глава 3. Медицина и риск	89
3.1. Понятие риска и основные теоретические подходы к его пониманию.....	89
3.2. Этика медицинского риска.....	95
3.3. Клинические решения в условиях риска	101
3.4. Врачебные ошибки и ятрогении.....	110
3.5. Безопасность в медицинских учреждениях	119
<i>Практикум</i>	<i>124</i>
Глава 4. Этика биомедицинских исследований.....	130
4.1. История биомедицинских экспериментов на человеке	130
4.2. Этические принципы биомедицинских исследований на человеке	134
4.3. Клинические исследования.....	141
4.4. Другие виды исследований с участием человека	149
4.5. Этика экспериментирования на животных	154
<i>Практикум</i>	<i>161</i>
Глава 5. Этические проблемы отдельных медицинских областей.....	167
5.1. Смерть и умирание в эпоху новых медицинских технологий	167
5.2. Моральные проблемы трансплантации органов и тканей	175
5.3. Репродуктивная этика и вмешательства в репродукцию человека	185
5.4. Этика в психиатрии	193
5.5. Эпидемия и этика (СПИД; морально-этические проблемы)	199
<i>Практикум</i>	<i>207</i>

Глава 6. Этические проблемы новых биомедицинских технологий 214

6.1. Инновационные технологии биомедицины 214

6.2. Медицинская генетика и геномная медицина 219

6.3. Этические проблемы прикладных генетических методов 226

6.4. Нейроэтика 233

6.5. Наномедицина и наноэтика 238

Практикум 244

Глава 7. Биоэтика и общество 250

7.1. Проблема справедливости в здравоохранении: теоретические основания 250

7.2. Проблема справедливости в здравоохранении: практические аспекты 256

7.3. Этические комитеты и этическое консультирование 265

7.4. Биоэтика и общественное здравоохранение 274

7.5. Проблемы гуманизации медицины 281

Практикум 287

Ответы..... 294

Литература 306

Предисловие

В учебнике изложены основы биоэтики как нового междисциплинарного направления. В нем отражаются ключевые проблемы теоретических оснований и практических приложений современного биоэтического знания.

Учебник соответствует базисной федеральной программе по данной дисциплине и предполагает приобретение необходимых компетенций. По завершении учебного курса учащиеся должны:

знать

- историю биомедицинской этики;
- теоретические основы биомедицинской этики;
- основные правила биомедицинской этики;
- основные этические документы профессиональных медицинских ассоциаций;
- Конвенцию о правах человека и биомедицине (Совет Европы, 1997);
- клятву российского врача;
- права и моральные обязательства врача;
- права пациентов;
- моральные нормы внутрипрофессиональных взаимоотношений;
- этические принципы проведения экспериментов на животных;
- сущность моральных проблем медицинской генетики;
- сущность моральных проблем трансплантации органов и тканей человека;
- суть морально-этических проблем, связанных с инфекционными заболеваниями и ВИЧ (СПИД);
- особенности морально-этических отношений в психиатрии;
- моральные основы предпринимательской деятельности в медицине;

уметь

- при разрешении моральных конфликтов руководствоваться интересами пациентов;
- защищать права пациентов на информацию, свободу выбора и свободу действий;
- защищать неприкосновенность частной жизни как основу человеческого достоинства пациентов;
- сохранять конфиденциальность (врачебную тайну);
- проявлять гуманность по отношению к лабораторным животным;
- проявлять такт и деликатность при общении с больными и родственниками больных людей;
- отстаивать моральное достоинство и чистоту медицинской профессии;

владеть

- навыками анализа моральных конфликтов в медицинской науке и практике;
- навыками поиска и принятия решений в защиту прав пациентов;
- навыками применения основных правил и принципов биомедицинской этики;
- навыками оценки моральных аспектов научно-медицинских исследований с участием людей;
- навыками оценки степени риска для испытуемых при проведении научно-медицинских исследований и предупреждения недопустимого риска;
- навыками исследования новых моральных проблем, связанных с научно-медицинскими открытиями и изобретениями, разработкой и применением инновационных медицинских технологий.

Учебник состоит из семи глав, которые охватывают вопросы от истории и теоретических основ биоэтики до конкретных проблем отдельных областей медицины и новых медицинских технологий, а также взаимоотношений медицины и общества в современном мире.

Издание адресовано студентам медицинских вузов и средних учебных заведений, преподавателям, практическим врачам и медицинским сестрам, организаторам здравоохранения, а также всем, кто интересуется этическими проблемами современной медицины. Оно соответствует уровню академического бакалавриата, может использоваться для обучения магистров, а также в системе последиplomного медицинского образования (для повышения квалификации практикующих врачей и организаторов здравоохранения) и в медицинских колледжах.

Данный учебный курс ориентирован прежде всего на подготовку в системе медицинского образования. Однако он может быть полезен также лицам, получающим гуманитарное образование (будущим философам, психологам и др.), в программу обучения или круг интересов которых входят также вопросы биоэтического знания.

Учебник, помимо теоретической части, включает практикум. Примеры и задачи, входящие в данный курс, помогут студентам лучше разобраться в особенностях биоэтики и получить первоначальные практические навыки. В практикуме даны разнообразные типы заданий: контрольные вопросы, задания и кейсы, которые потребуют от студента разбора ситуаций, участия в дискуссиях, работы с документами. Задания повышенной трудности отмечены звездочкой (*). Некоторые вопросы биоэтики, которые имеют дополнительный характер по отношению к основному содержанию курса, вынесены в практикум и предполагают самостоятельную работу учащихся.

Учитывая то, что современная биоэтика является бурно развивающимся полем обсуждений и исследований, в учебник включены некоторые наиболее дискуссионные сюжеты последнего времени. Современная биоэтика остается областью не прекращающихся споров, разработкой новых этических теорий и прикладных методов этического анализа, а также практической деятельностью по защите важнейших ценностей общества в условиях стремительного прогресса современной медицинской науки и технологии.

Глава 1

ИСТОРИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОЭТИКИ

После изучения первой главы студент должен:

знать

- основные исторические этапы развития традиционной медицинской этики и современной биоэтики;
- предметную сферу биоэтики и основные характеристики биоэтики как социального института;
- основные этические концепции биоэтики;
- основные теоретико-методологические подходы биоэтики;

уметь

- охарактеризовать суть проблемы качества жизни в медицине и биоэтике;
- различать основные уровни морального рассуждения при принятии решений и оценке действий;

владеть

- первоначальными навыками анализа моральных проблем медицины;
 - первоначальными навыками работы над международными биоэтическими документами.
-

1.1. История развития медицинской этики и биоэтики

История медицинской этики

Истоки моральных заповедей, обращенных к деятельности врача, уходят в далекую древность. Когда появляются первые письменные источники по медицине, описывающие лечебные практики, рецепты, хирургические инструменты и т.п., тогда же возникают и письменно изложенные требования к врачу, которые предписывают ему определенные правила поведения, принципы отношения к больным, моральные обязательства.

Дошедший до нас кодекс царя вавилонского Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) содержит в том числе правовую регуляцию деятельности вавилонских врачей. В этом древнейшем источнике медицинского законодательства указывается, например, что за успешную хирургическую операцию врачу причитается вознаграждение, а при неудачном исходе ему надлежит отсечь руки.

Медицина Древней Индии тоже уделяла внимание моральным требованиям к врачу. Знаменитые индийские врачи — терапевт Чарака

(примерно II в. н.э.) и хирург Сушрута (IV в. н.э.) — составили важнейшие трактаты по индийской медицине — «Чарака-самхита» и «Сушрута-самхита». Помимо вопросов медицинской практики, в них описываются также обязанности врача, необходимые нравственные качества, правила поведения по отношению к больным.

В древние времена этические кодексы врача нередко принимали форму так называемых клятв. Конечно, самой знаменитой, прошедшей через всю историю медицины и известной каждому современному медицинскому работнику, является клятва Гиппократовых. Клятвы, в которых содержались основные моральные нормы поведения врача, существовали и во врачебных школах Древней Греции, а также в других странах (Древнем Египте, Индии и др.). Сам факт существования таких ритуалов говорит о том, что врачевание издавна понималось как деятельность, имеющая очень глубокий моральный и даже священный смысл.

Знаменитый древнегреческий врач Гиппократ (около 460—370 до н.э.) традиционно считается отцом медицины. Достоверных сведений о его жизни довольно мало. Он родился и жил на о. Кос, занимался врачебным делом, однако при этом много путешествовал по греческим городам. До нашего времени сохранилась большая коллекция медицинских работ (72 рукописи), которые принято называть «Гиппократовым сборником», или «Корпусом Гиппократовых» (*Corpus Hippocraticum*). На самом деле этот сборник был составлен позже учеными в Александрии (III в. до н.э.), причем в него попали работы, написанные различными авторами из разных медицинских школ. Поэтому определение настоящих работ Гиппократовых — это сложная задача для историков медицины, до сих пор не имеющая удовлетворительного решения.

В «Гиппократовом сборнике» много внимания уделяется проблемам врачебной этики. Наибольшую известность в последующие века приобрела «Клятва». Помимо этой работы, вопросы врачебной морали в той или иной степени отражены в таких произведениях, как «Закон», «Об искусстве», «О враче», «О благоприличном поведении», «Наставление», «Афоризмы» и др. Они показывают, как много значения уже в Древней Греции придавалось воспитанию надлежащих качеств врача: его нацеленности на благо больного, ответственности, справедливости, образцовому поведению.

В работах Гиппократовых сборника содержится ряд важнейших положений медицинской этики, которые значимы до сегодняшнего дня. Среди них можно назвать уважение к больному человеку, непричинение вреда врачебными действиями (не вреди), соблюдение врачебной тайны, проблему информирования пациентов об их состоянии здоровья, запрет на участие врача в эвтаназии и искусственном прерывании беременности, взаимоотношения врачей (или принципы коллегиальности), проблему допустимости интимных отношений врача и пациента и др.

Отражена и такая деликатная проблема медицинской этики, как вознаграждение за оказанную врачебную помощь. В частности, в «Наставлении» говорится о том, что в любом случае на первом месте у врача должна быть помощь больному.

Практически все этические вопросы, которые обсуждались в Гиппократовом сборнике, позже стали предметом дискуссий и более углубленных исследований.

К основным принципам этики Гиппократа, на которых базировались более конкретные моральные предписания, можно отнести следующие:

- высокий моральный облик врача — основа врачебной деятельности в целом;

- стремление к благу для пациента;
- непричинение вреда;
- уважение и защита ценности жизни.

Этические взгляды Гиппократа оказали значительное влияние на последующее формирование медицинской этики в Европе. Работы из «Гиппократова сборника» (и особенно клятвы) стали первым письменным сводом правил поведения врача, на основе которого в дальнейшем шло обсуждение этических вопросов медицины и развитие медицинской этики в целом.

В эпоху Средневековья представления о моральных основах врачевания оказываются под сильным влиянием религии. Сами понятия «врач» и «врачебная помощь» переосмысливаются в свете христианских ценностей. На первый план выходят такие христианские добродетели, как любовь к ближнему, сострадание к страждущим (в том числе к больным и немощным), милосердие. Это сказалось, в частности, и в том, что в Средние века при монастырях стали создаваться приюты и лечебницы, где помощь оказывалась бесплатно, из милосердия и сострадания.

В конце IX в. в Европе появляется первая медицинская школа в г. Салерно (Италия), расцвет которой приходится на X—XIII вв. Салернская школа возрождает гиппократовские традиции медицины, что подчеркивалось и ее названием — «Гиппократова община». Она послужила образцом для других медицинских школ Европы, прежде всего для учебных центров в Болонье, Париже, Падуе.

Существенный вклад в развитие медицины внесла в эпоху Средних веков арабская цивилизация. Из известных ученых арабского Средневековья следует назвать в первую очередь Ибн Сину (Авиценну) (980—1037). Он написал более 400 работ в разных областях знания, но его главным трудом является знаменитый «Канон медицины». Хотя в этой книге нет специального раздела по врачебной этике, Авиценна уделяет много внимания этической стороне врачевания, в том числе необходимости достижения блага для больного и непричинения вреда.

Знаменитый еврейский врач Моисей Маймонид (1135—1204) жил в Кордове, но потом подвергся гонениям и нашел пристанище в Каире. В своих медицинских трудах (посвященных вопросам гигиены, здорового образа жизни и др.) он уделяет внимание и медицинской этике. Широкую известность приобрела, в частности, его «Молитва врача», в которой описываются важнейшие добродетели врача (кротость, терпение, бескорыстие и др.).

Один из самых ярких представителей медицины в эпоху Возрождения (XIV—XVI вв.) — знаменитый врач и химик Парацельс (1493—1541), решительный реформатор медицинской науки и практики, призывавший вни-

мательно учиться у самой природы. Этические представления Парацельса основаны на моральном принципе «делай добро». В своих работах ученый придает высокий духовно-нравственный смысл делу врачевания, а также отношениям врача и пациента. Он утверждает, что глубокое душевное взаимопонимание врача и пациента является основой лечебного процесса.

В эпоху Нового времени (с XVII в.) разворачивается революционное обновление научного знания, формируются начала точного естествознания. Такие выдающиеся деятели науки и философии, как Ф. Бэкон и Р. Декарт, требуют обосновать весь проект научного познания целиком заново. Это сказывается и на новом, более решительном и амбициозном, определении самих задач медицинской науки. Свое видение будущего медицины Ф. Бэкон ясно выразил в сочинении *De Dignitate et Augmentis Scientiarum* — «О достоинстве и приумножении наук». Критикуя традиционные медицинские воззрения, Бэкон требует проведения систематических исследований человеческого организма, а также экспериментов на животных, что должно создать научную базу для правильного понимания здоровья и болезней.

Стратегическими целями новой медицины Бэкон объявляет:

- 1) сохранение здоровья;
- 2) лечение болезней;
- 3) продление жизни.

При этом он обсуждает также этические проблемы отношения к неизлечимым больным, оказания им необходимой помощи. Следует отметить, что именно Ф. Бэкон ввел термин «эвтаназия», который позже стал широко использоваться в дискуссиях по медицинской этике.

В эпоху Просвещения (XVIII в.) известный шотландский врач и философ Джон Грегори (1724—1783) стремится построить философский базис для врачебной этики, создать единую этическую систему медицинской деятельности. Этот замысел во многом базировался на моральной философии знаменитого шотландского философа Д. Юма, в том числе на его теории морального чувства. В своей работе «Лекции об обязанностях и квалификации врача» (1772) Грегори исследует проблему взаимоотношений врача и пациента и приходит к выводу, что врач должен развивать особую «чувствительность сердца», т.е. умение понимать пациента, чувствовать вместе с ним, вживаться в его переживания.

В начале XIX в. английский терапевт Томас Персиваль (1740—1804) опубликовал книгу «Медицинская этика», что стало важнейшей вехой в развитии этой области знания, особенно в англоязычном мире. В данной работе ученый рассматривает ряд важнейших вопросов медицинской этики: отношение врача к пациенту, взаимоотношения между врачами, обязанности фармацевтов и больничного персонала, других медицинских работников. Книга Т. Персиваля, в частности, оказала влияние на принятый впоследствии Американской медицинской ассоциацией «Этический кодекс врача».

В XIX в., помимо развития врачебной этики, начинается формирование этики сестринского дела (или сестринской этики). Основательницей профессии медицинской сестры считается Флоренс Найтингейл (1820—1910), организовавшая в Великобритании первую школу медицинских сестер. Она с самого начала уделяла большое внимание этическим аспектам ра-

боты медицинской сестры, показывала различия врачебной и сестринской деятельности, настаивала на необходимости развития высоких моральных качеств, которыми должна обладать медицинская сестра (рис. 1.1).



Рис. 1.1. Флоренс Найтингейл (1820—1910), сестра милосердия, общественный деятель, основательница профессии медицинской сестры

В конце XIX в. начинают выходить профессиональные журналы по сестринскому делу, создается Международный совет медицинских сестер (1899). А в 1900 г. выходит одна из первых работ, посвященных этике сестринского дела, — книга И. Х. Робб «Сестринская этика для госпиталей и частного применения». Сама И. Робб (1860—1910) внесла значительный вклад в развитие сестринского дела в США.

Интенсивное развитие медицинской этики в XX в. привело к тому, что, несмотря на разногласия и дискуссии, медицинское сообщество стало приходить к международно признанным представлениям о моральных нормах медицинской профессии. В частности, это выразилось в принятии ряда международных кодексов медицинской этики. Среди них Женевская декларация (1948) — новый вариант клятвы врача; Международный кодекс медицинской этики (1949); Международный этический кодекс медицинской сестры (1953) и др.

В дореволюционной России развитие медицинской этики связано с именами замечательных отечественных врачей, таких как М. Я. Мудров, Н. И. Пирогов, С. П. Боткин, В. А. Манассеин и другие. В частности, важную роль в развитии медицинской этики в нашей стране сыграл В. А. Манассеин (1841—1901), профессор Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Его называли совестью врачебного сословия. В своих работах В. А. Манассеин поднимает множество актуальных вопросов медицинской этики — взаимоотношения между врачами, отношение к больному, проблемы врачебной тайны и др.

Развитие сестринского дела в России находилось на довольно высоком уровне. Здесь стоит вспомнить, что само появление медицинских сестер произошло во время Крымской войны 1853—1856 гг. практически одновременно в России и Великобритании. К концу XIX в. в России в общинах

сестер милосердия ведется специальная подготовка, включающая более десятка дисциплин медицинского характера. Кроме того, много внимания уделялось моральным аспектам сестринского дела. Будущие сестры милосердия изучали специальные дисциплины религиозного и социального содержания, воспитывались в русле необходимых для сестринского дела религиозных и моральных представлений, овладевали навыками оказания психологической помощи своим подопечным.

В советский период медицинская этика оказалась в сложном положении. Официальная идеология советской системы здравоохранения состояла в том, что врач в советском государстве должен руководствоваться коммунистической моралью, а медицинская этика как отдельная область морали считалась буржуазным пережитком.

Тем не менее с конца 30-х гг. XX в. выдающийся отечественный онколог Н. Н. Петров стал разрабатывать медицинскую деонтологию как учение об обязанностях медицинских работников. Постепенно отношение к вопросам медицинской этики в Советском Союзе стало улучшаться (хотя сам термин «медицинская этика» практически не использовался), стали появляться публикации, посвященные этическим проблемам медицины, было введено преподавание медицинской деонтологии в медицинских вузах, а также утвержден текст присяги советского врача.

Но полноценное развитие медицинской этики и биоэтики начинается в нашей стране только с 90-х гг. XX в. — уже в Российской Федерации.

Формирование биоэтики

С 60-х гг. XX в. ситуация в медицине стала стремительно меняться: моральные проблемы медицины и здравоохранения стали все настойчивее привлекать внимание самых разных кругов общественности. Это было связано с множеством причин.

Прежде всего следует отметить революционные изменения в медицинской науке и практике. В послевоенный период XX в. медицина вступила в эпоху бурного развития, за короткий срок было создано множество новых технологий, которые резко расширили возможности медицины. Примерами могут служить новые аппараты для интенсивной терапии и реанимации, возрастающая эффективность операций по пересадке органов, появление новых репродуктивных технологий, успехи в области генетики и геномной инженерии. Однако применение этих технологий вызвало к жизни множество совершенно новых моральных проблем, которые требовали углубленного обсуждения.

Параллельно с успехами медицины появилась такая проблема, как дефицит дорогостоящего лечения, неспособность систем здравоохранения обеспечить им всех нуждающихся. Этому способствовало и понимание того, что рост расходов на здравоохранение (с которым столкнулись все развитые страны) необходимо сдерживать, так как неконтролируемые затраты на здравоохранение способны подорвать бюджет даже самой богатой страны. Но здесь возникает острейшая моральная проблема — необходимость справедливого распределения ограниченных медицинских ресурсов. Она привлекла к себе повышенное внимание и специалистов, и общественности.

Еще одна причина возрастающего интереса к этическим проблемам медицины — общее развитие гражданского общества и демократических институтов в послевоенную эпоху. В мире усиливаются различные правозащитные движения, в том числе занимающиеся правами отдельных групп и решением конкретных общественных проблем.

В русле этого общего процесса развития демократии особое место стала занимать проблема защиты прав пациента, пересмотра той власти, которой врачи традиционно обладали по отношению к своим больным, создания более сбалансированной системы взаимоотношений в системе здравоохранения, особенно по отношению к наиболее уязвимым категориям пациентов (душевнобольным, недееспособным, престарелым и др.).

Растущая сложность медицинской практики привела, в свою очередь, к постепенному усложнению ее регуляции. Появилось множество новых форм контроля за медициной и здравоохранением: государственное регулирование, страховые компании, антимонопольные органы, судебный контроль, влияние со стороны общественных движений. Кроме того, работу медиков стали контролировать и специальные этические комитеты (впервые они стали возникать в 1960-е гг. в США).

В итоге медицинское сообщество начало утрачивать так называемую профессиональную автономию — способность полностью самостоятельного принятия решений по поводу медицинских вмешательств и самостоятельной разработки нормативов медицинской деятельности. Все эти изменения (которые продолжаются и сейчас) имеют подлинно революционное значение с точки зрения всей истории медицины.

Отдельной областью, привлекавшей все более широкое внимание общества, стала исследовательская этика в медицине и биологии. Испытания на людях, которые проводились все масштабнее (и этого требовали интересы дальнейшего развития медицинской науки), порождали множество новых моральных проблем. Регуляция медицинских исследований на основе хорошо обоснованных этических кодексов и под надежным независимым контролем становилась все более насущной задачей.

Более того, с продвижением биомедицинских исследований в сферу этических проблем оказались вовлечены новые биообъекты (гены, генетически модифицированные организмы, зародыши и др.), что стало создавать совершенно уникальные моральные ситуации.

Эти и многие другие причины привели к тому, что в обществе стала осознаваться необходимость в создании новой области знаний, посвященной новой ситуации в медицине и ее новым моральным проблемам. Эта область знаний должна быть междисциплинарной по своему характеру, объединять различные науки и направления.

В 1971 г. появляется термин «биоэтика». Его ввел в оборот американский ученый Ван Ренселлер Поттер в своей книге «Биоэтика. Мост в будущее», в которой он предлагает проект новой области знания, призванной связать биологические науки и общечеловеческие ценности и установить ориентиры дальнейшего продвижения научного познания. Ученый рассматривает биоэтику как некую новую науку, «науку выживания», которая сможет стать своеобразным мостом в будущее. Таким образом, Р. В. Поттер (рис. 1.2) понимает биоэтику скорее в глобально-экологическом смысле.



Рис. 1.2. Ван Ренселлер Поттер (1911–2001)¹

Термин «биоэтика» оказался очень удачным, однако сам проект Р. В. Поттера был несколько дальше от области моральных проблем медицины, непосредственно связанных с медицинской наукой и практикой.

Другой известный американский ученый (специалист в области акушерства и демографии) Андре Хеллегерс представил иное понимание задач биоэтики как области знаний, призванной установить взаимодействие между этикой и медициной. Именно это представление о задачах биоэтики в конечном счете нашло широкое признание. Сам Хеллегерс был одним из первых пропагандистов этой новой области и активно содействовал дальнейшему развитию биоэтики как в академической среде, так и среди широкой общественности.

Биоэтика — не просто расширение традиционной медицинской этики. Она является продуктом сложных изменений и отражает совершенно новую ситуацию как в медицинских науках, так и в обществе в целом. Биоэтика начала свое формирование как новое междисциплинарное направление, развивающееся на стыке множества наук и областей деятельности: медицины и биологии, философии, богословия, права, правозащитных движений, социальных исследований и др.

1.2. Предметная сфера биоэтики

Биоэтика как дисциплина

Этика — это философская дисциплина, объектом изучения которой являются фундаментальные представления общества о добре и зле, должном поведении человека, закрепленные в нравственных нормах.

Но, как мы видели, биоэтика выходит далеко за пределы сугубо философских исследований и является широким междисциплинарным полем. Современная биоэтика занимается очень обширным кругом вопросов, поэтому дать ей точное определение довольно трудно. Вот одно из возможных.

¹ URL: http://academictree.org/photo/006/cache.057216.Van_Potter.jpg.

Биоэтика — это междисциплинарная область исследований и обсуждений, предметом которой являются моральные основания и проблемы медицины и здравоохранения, а также тесно связанных с ними современных научных направлений (таких как биология, генетика, биотехнология, науки о сознании и др.).

С некоторой долей условности можно выделить два основных уровня биоэтических исследований:

- во-первых, современная биоэтика занимается изучением конкретных проблем, относящихся к медицинской деятельности в широком смысле (медицинская помощь, научные исследования, биомедицинские технологии, политика медицины и др.);
- во-вторых, на более общем философском уровне биоэтика занимается обсуждением и прояснением ценностных оснований современной медицины, ее морального содержания, смыслов и фундаментальных задач.

Основная цель биоэтических обсуждений и исследований может быть определена как *анализ* ценностно-нормативных проблем современной медицины и *поиск* их решений.

В зарубежной биоэтике нередко высказывается мнение, что эта дисциплина должна заниматься лишь *прояснением* этических проблем, т.е. вскрывать их суть, интерпретировать их с разных точек зрения, но при этом не претендовать на предоставление окончательных решений.

Но биоэтика в целом как отдельная научно-практическая область не может останавливаться только на прояснении проблем без стремления дать их обоснованное решение. Она имеет конструктивную практическую направленность. Уже сама история развития биоэтики в XX в. показывает, что эта дисциплина возникла на основе реальных потребностей медицины и общества как реакция на новые моральные ситуации. Уже первые работы основоположников биоэтики были нацелены на разработку новых принципов, подходов, методов решения моральных дилемм.

Поэтому правильнее было бы утверждать, что биоэтика направлена на систематическое содействие конкретным мероприятиям по решению этических проблем медицины — разработку законодательства, этических кодексов, регуляторной политики, правил и протоколов проведения биомедицинских исследований, предоставление помощи в принятии решений в клинической практике и др.

Иными словами, задачи биоэтики как особой научно-практической области — способствовать конкретным мероприятиям по решению моральных проблем современной медицины и смежных наук.

Структура предметной сферы биоэтики

Современная биоэтика подразделяется на множество направлений. Границы между ними весьма условны, так как эти направления тесно взаимодействуют между собой. Кроме того, поскольку биоэтика бурно развивается, многие области находятся в состоянии формирования и еще не полу-

чили собственного названия и оформления. Поэтому вопрос о структуре предметной сферы биоэтики довольно сложен.

Термины «биоэтика» и «биомедицинская этика» часто употребляются как синонимы. В нашем учебнике мы тоже будем считать их синонимами.

Но существует и другое мнение, согласно которому биоэтика — это название для более общей области, в рамках которой можно выделять более конкретные и специализированные дисциплины.

С этой точки зрения структура предметной сферы биоэтики будет выглядеть примерно так.

Биоэтика — наиболее общая область, представляющая собой этику отношения к жизни вообще, в том числе к биосфере в целом, а также к биосистемам и живым организмам (фактически это понимание биоэтики, близкое тому, которое предложил Р. В. Поттер). В частности, сюда можно отнести такие направления, как биоэтика окружающей среды и биобезопасность (направление, тесно связанное прежде всего с развитием генной инженерии).

Биомедицинская этика — междисциплинарная сфера, в центре внимания которой находится человек, его жизнь, здоровье, достоинство, качество жизни и т.п. — все, что связано с медициной и здравоохранением. *Предмет биомедицинской этики* — это обсуждение моральных проблем медицинской науки и практики, а также смежных направлений.

Медицинская этика — составная часть биомедицинской этики. Традиционный *предмет медицинской этики* — этическая сторона взаимоотношений врача и пациента. Современная медицинская этика анализирует моральные проблемы медицинской деятельности в узком смысле (отношения врача и пациента, основные моральные принципы медицинской практики, отношения внутри медицинского сообщества и др.).

Клиническая этика — этот термин часто рассматривается как синоним медицинской этики. Однако клиническую этику иногда понимают также в более специальном смысле — как этический (или этико-правовой) анализ реальных ситуаций медицинской практики, исследование конкретных клинических случаев (так называемых кейсов), анализ принятия конкретных клинических решений, разбор коллизий, возникающих в медицинской работе и т.п.

Кроме того, в рамках биомедицинской этики можно выделить ряд относительно самостоятельных, более или менее оформившихся направлений, или субспециальностей. К ним можно отнести, например, *этику биомедицинских исследований* (исследовательскую биоэтику), *фармацевтическую биоэтику*, *биоэтику в психиатрии*, *репродуктивную биоэтику* (которая занимается моральными проблемами вмешательств в репродукцию человека), *геронтоэтику* (изучающую этические проблемы помощи пожилым людям) и др.

Биомедицина как предмет исследований биоэтики

Сегодня часто используется термин «биомедицина», что отражено также в самом понятии «биомедицинская этика». Уже говорилось, что современная биоэтика — это не просто расширение традиционной медицин-

ской этики, но совершенно новая область знаний, связанная с крупными изменениями в медицинской науке и практике. Одной из существенных причин формирования биоэтики (или биомедицинской этики) явилось возникновение такого нового феномена, как биомедицина. Итак, что такое биомедицина?

Термин «биомедицина» стал применяться с 50-х гг. XX в. и получил повсеместное распространение к рубежу XX—XXI вв. Его используют преимущественно в отношении наиболее высокотехнологичных стремительно развивающихся отраслей медико-биологических наук — таких, например, как молекулярная генетика, биоинформатика, биоинженерия, трансплантология, регенеративная медицина. Более того, это понятие выступает в некотором смысле как синоним современной медицины вообще.

Как видно из самого этого названия, биомедицина есть некоторое объединение биологии и медицины. Точнее, под биомедициной можно понимать современную общемедицинскую установку на систематическое *применение* фундаментальных *биологических знаний* и биотехнологий *к медицинским задачам* диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и др.

Именно здесь ожидаются наиболее решающие открытия и достижения, способные вывести медицину к совершенно новым рубежам. Таким образом, биомедицина — это центральная тенденция современного прогресса в медицине.

Как показывают зарубежные исследователи П. Китинг и А. Камбросио в работе «Медицинские платформы», несмотря на то что связи между биологическими и медицинскими науками существуют уже давно, современная биомедицина есть совершенно новая организационная и научная активность, при которой медицинские задачи все больше «переводятся» на язык фундаментальной биологии. Однако исследования, которые начинаются как прикладные, могут принести фундаментальные биологические результаты¹.

Следует также отметить, что воздействие биомедицины как прогрессирующего научного предприятия оказывается чрезвычайно обширным, его можно найти во множестве проявлений, порой весьма отдаленных от первоначальных научных установок биомедицины. Биомедицина пронизывает своим влиянием фактически всю современную медицину. Например, это воздействие сказывается на базисных ценностях медицинского образования (на чем должна строиться система подготовки врачей и т.п.), приоритетности научно-медицинских разработок, состоянии взаимоотношений врача и пациента, престижности медицинских специальностей и др. В свою очередь, это создает массу новых проблем для биомедицинской этики.

Основные проблемные поля биоэтики

Проблематика биоэтики сегодня поистине необозрима, поэтому трудно дать какую-то приемлемую ее классификацию. Весьма условно можно вы-

¹ См.: Keating P., Cambrosio A. Biomedical Platforms. Realigning the Normal and the Pathological in Late-Twentieth-Century Medicine. Cambridge : MIT Press, 2003.

делить несколько основных областей биоэтических исследований и обсуждений, которые, впрочем, не имеют четких границ и зачастую пересекаются между собой. Эти области представляют собой некие устойчивые комплексы, которые постоянно порождают моральные дилеммы и биоэтические дискуссии. К ним можно отнести следующие.

1. Разработки биомедицины. Эта проблемная область связана с теми новыми горизонтами, к которым вышла или намеревается выйти медико-биологическая наука и технология. Речь идет о наиболее инновационных, революционных разработках биомедицинской науки, которые создают фундаментальные вызовы культурного, социального, морального характера. Социокультурные следствия таких исследований входят в конфликт с более традиционными представлениями и меняют наши взгляды на общечеловеческие ценности, стирают важнейшие культурные различия (между человеком и машиной, искусственным и естественным и др.).

К этой проблематике можно отнести дискуссии по поводу молекулярной генетики, репродуктивных технологий, биомедицинских нанотехнологий, ксенотрансплантаций, создания прямых взаимодействий «мозг — компьютер» и многих других разработок.

2. Права и справедливость. Это сфера сложных этических, социальных, политических проблем медицинской науки и практики, где на первый план выходят вопросы защиты прав человека и особых групп общества, таких как люди с ментальными отклонениями (психическими заболеваниями), нетрудоспособностью, ВИЧ-инфицированные, женщины, пожилые, дети, больные той или иной формой тяжелой патологии. Здесь обсуждаются вопросы справедливого доступа к благам медицинской науки и технологии, преодоления дискриминации, права на уважительное отношение со стороны общества и понимания проблем обездоленных людей.

3. Пациент и процесс медицинской помощи. Эта сфера проблем ближе к традиционной медицинской этике. Здесь в фокусе внимания находятся взаимоотношения пациента и врача (шире — пациента и медицинского персонала) и конкретные ситуации медицинской помощи.

К этому кругу тем можно отнести вопросы информированного добровольного согласия, конфиденциальности, автономии пациента, принятия решений за пациента, выбора представителя пациента, поиска клинических решений в этически сложных ситуациях и другие проблемы. Сюда же следует включить проблемы внутренних взаимоотношений в среде медицинской профессии (рабочие конфликты, этика проведения консилиумов, этические проблемы профессиональных субординаций и др.).

4. Этика научно-медицинских исследований. Как уже говорилось, данное проблемное поле оформилось в самостоятельное биоэтическое направление под названием «исследовательская этика» (англ. *research ethics*). К нему следует отнести, прежде всего, вопросы регуляции экспериментов на человеке, защиту его прав и достоинства в процессе исследований.

Кроме того, эта область проблем частично пересекается с первым проблемным полем (обсуждение разработок биомедицины), поскольку с продвижением биомедицины нарастают вопросы о моральной допустимости

исследований в определенных областях или на определенных объектах (половые клетки, эмбрионы, гены, стволовые клетки и др.).

5. Цели и моральные смыслы медицины. Наконец, можно выделить особую область биоэтических дискуссий, которые идут на более общем уровне по поводу медицины вообще и касаются содержания самой медицинской деятельности в современном мире: «Какой она должна быть? В чем ее подлинные цели? Где ее границы? Чем может и чем не может заниматься медицина?»

К примеру, это дискуссии о том, как следует относиться к эвтаназии, может ли медицина выступать как инструмент власти и контроля над обществом, превращаться в проект технизации самой человеческой природы или «улучшения» человечества и т.п.

Помимо указанных основных проблемных областей, существует немало других тем биоэтических обсуждений, которые трудно отнести к какой-то из вышеперечисленных.

Биоэтика как социальный институт

На сегодняшний день биоэтика — не только сложившееся направление со своими учебными курсами, кафедрами, профессиональными журналами (то, что можно назвать академической биоэтикой); она стала также самостоятельным и очень значимым социальным институтом современного общества.

Под **социальным институтом** понимают устойчивую структуру общества, регулирующую определенный вид общественных отношений или общественной деятельности. Специфика биоэтических проблем придает социальному институту биоэтики некие *особенные черты*, тесно связанные между собой. Среди них следует назвать следующие.

1. *Междисциплинарность.* По самому своему характеру биоэтика способствует привлечению представителей самых различных областей и направлений (философов, врачей, ученых, биологов, юристов, политиков и др.), а также широкой общественности.

2. *Дискуссионный характер обсуждений.* Биоэтика занимается множеством сложных проблем, которые порой очень далеки от решения, поэтому нередко уже само их обсуждение и прояснение может иметь большое значение.

3. *Плюрализм точек зрения.* Биоэтические дискуссии чаще всего проходят в ситуации идейных разногласий и наличия множества точек зрения. Поэтому для обсуждения биоэтических проблем требуются такие условия, как равенство участвующих сторон, уважение к оппонентам, умение вести рациональную дискуссию, нацеленность на достижение рационального согласия. В некотором смысле, биоэтические обсуждения конкретных проблем являются демократией в действии (или, по крайней мере, должны стремиться к этому, как к идеалу).

4. *Открытость.* Биоэтика с самого начала формировалась не как узкая академическая дисциплина, закрытая для непосвященных, а, напротив, как открытая междисциплинарная область. Поэтому для участия в обсужде-

ниях биоэтических проблем возможно привлечение любых заинтересованных групп общественности, а также их представителей и конкретных лиц.

Сегодня в обсуждении биоэтических проблем участвуют правительства и парламенты, религиозные организации, общественные движения, объединения пациентов, правозащитники, писатели и журналисты — иными словами, поле биоэтических дискуссий выступает как своеобразный публичный форум, посредством которого общество оказывает свое влияние на положение дел в медицине, здравоохранении и медико-биологических науках.

Что входит в структуру современной биоэтики как социального института? Эта структура представлена самыми разнообразными составляющими. К ним можно отнести, в частности, следующие.

1. *Академическая биоэтика*, т.е. профессиональное сообщество специалистов по биоэтике, включая сотрудников специализированных кафедр, научных центров по биоэтике, а также специалистов-консультантов.

2. *Этические комитеты*, деятельность которых сегодня имеет довольно обширный характер и оказывает существенное влияние на медицину и здравоохранение.

3. *Этические комиссии, советы, рабочие группы* на правительственном и международном уровне.

4. *Объединения представителей медицинского сообщества*, участвующие в разработке этических документов и решении биоэтических проблем (например, влиятельная международная организация ВМА — Всемирная медицинская ассоциация).

5. *Организованные объединения пациентов* и членов их семей.

6. *Общественные движения* (правозащитные, религиозные, экологические и др.), занимающиеся вопросами биоэтики.

Международные документы по биоэтике

В процессе развития биоэтика приобрела влиятельный международный статус, что выразилось в создании множества международных структур и организаций, проведении международных конференций и исследований, а также в принятии ряда важнейших международных документов, посвященных различным проблемам биоэтики.

Среди важнейших международных биоэтических документов следует назвать следующие:

- Нюрнбергский кодекс (1947);
- Женевская декларация (международная клятва врача) (ВМА, 1948);
- Международный кодекс медицинской этики (ВМА, 1949);
- Хельсинкская декларация (ВМА, принята в 1964 г., последняя редакция 2013 г.);
- Лиссабонская декларация о правах пациентов (ВМА, 1981);
- Декларация по продвижению прав пациентов в Европе (Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 1994);
- Конвенция Совета Европы «О правах человека и биомедицине» (1997); полное название — «Конвенция о защите прав и достоинства чело-

века в связи с применением достижений биологии и медицины» (с последующими дополнительными протоколами);

- Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека (ЮНЕСКО, 1997);
- Рекомендации комитетам по этике, проводящим экспертизу биомедицинских исследований (ВОЗ, 2000);
- Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека (ЮНЕСКО, 2005);
- Рекомендации Совета Европы относительно исследований, проводимых на биологических материалах человеческого происхождения (2006).

Международные биоэтические документы имеют огромное значение для соблюдения широко признанных норм и установленного порядка решения проблем, хотя правовой статус этих документов, строго говоря, не одинаков. Одни документы являются международными договорами и имеют обязательную силу (для стран, их ратифицировавших). Как правило, договорной характер имеют в международном праве такие документы, как конвенции и пакты. Впрочем, и для стран, не ратифицировавших международные договоры, такие документы очень важны, так как оказывают на них моральное и политическое влияние, заставляя считаться в той или иной мере с международными нормами.

Другие международные документы не имеют обязательной силы и служат лишь рекомендациями (как правило, это декларации, хартии, принципы, собственно рекомендации и др.). Однако они тоже оказывают сильное влияние на политику государств, а некоторые (как, например, Всеобщая декларация прав человека) могут приобрести статус обычного международного права.

1.3. Теоретические основы современной биоэтики

Проблема метода в биоэтике

С самого начала развития новой дисциплины биоэтики решающее значение для нее приобрела проблема метода: «Какими способами следует выносить этические оценки и суждения по поводу тех или иных реальных проблем медицинской практики, биомедицинских исследований, взаимоотношений медицины и общества и т.п.?»

Этика — древнейшая область философского знания, но единой теоретической системы этики так и не было построено, несмотря на огромное количество разработок. Более того, проблемы теоретической этики осложняются тем, что в современном обществе утвердился так называемый *моральный релятивизм*. Под этим понимают сосуществование в обществе множества различных систем ценностей. К примеру, для одних людей и групп важнейшую роль играет религия (причем в одной и той же стране живут представители разных религий), для других — различные светские нерелигиозные системы взглядов (и они тоже могут очень различаться).

Моральный релятивизм создает серьезный вызов для биоэтики, а именно — он затрудняет выработку единых подходов к решению практи-

ческих проблем медицины и здравоохранения, в то время как для решения этих актуальных жизненно важных вопросов требуются не увлекательные дискуссии, а внятные обоснованные суждения.

Поэтому формирование биоэтики происходило в трудных условиях поисков собственных методов морального рассуждения. Этот процесс разработки методов продолжается и до сих пор.

Среди множества предложенных вариантов развития биоэтики как дисциплины можно выделить два основных подхода:

- 1) подход, основанный на принципах (англ. *principle-based*);
- 2) подход, основанный на анализе случаев, или прецедентов (англ. *case-based*).

Каждый из них сам по себе тоже распадается на массу вариантов. Рассмотрим вкратце эти два подхода.

Подход, основанный на принципах

Первый подход отталкивается от следующей идеи: метод биоэтики должен использовать какие-то ясные, не вызывающие сомнений моральные принципы и применять их для решения конкретных проблем медицины. Иными словами, мы должны прежде всего выбрать надежную точку опоры, с помощью которой можно решать все (или по крайней мере, большинство) моральных проблем медицинской науки и практики.

В виде такого морального основания могут выступать либо какая-то одна хорошо обоснованная этическая теория (или этический принцип), либо какой-то небольшой набор исходных принципов.

Подход, основанный на принципах, приобрел огромную популярность в биоэтике. Наверное, самым известным вариантом является подход американских специалистов Томаса Бичампа и Джеймса Чилдреса, изложенный в их книге (многократно переиздававшейся) «Принципы биомедицинской этики». Эта работа во многом способствовала формированию биоэтики как таковой, в том числе повлияла на образовательные программы, учебники, академические исследования начального периода развития новой дисциплины.

Вариант Бичампа — Чилдреса позже получил даже особое название — «принципализм» (англ. *principlism*), которое было придумано его критиками.

Еще одно название концепции Бичампа — Чилдреса — «подход четырех принципов». Действительно, этот подход принимает в качестве базиса биомедицинской этики четыре исходных требования:

- 1) *автономия пациента (autonomy)*;
- 2) *не вредить (nonmaleficence)*;
- 3) *действовать во благо (beneficence)*;
- 4) *справедливость (justice)*.

Кроме того, из этих принципов вытекает ряд производных *правил* биомедицинской этики, которые имеют более конкретный характер, например правила правдивости и конфиденциальности.

По причине огромной популярности подхода Бичампа — Чилдреса мы рассмотрим его подробнее далее (см. параграф 1.4).

Примером еще одного варианта подхода, основанного на принципах, может служить концепция известного американского биоэтика Р. Витча, изложенная им в работе «Теория медицинской этики» (1981). Он предлагает, в общем, похожий набор исходных моральных принципов: это стремление к благу, соблюдение контракта (*contract-keeping*), автономия, честность, не причинять вред (не убивать), справедливость; однако его подход несколько отличается с точки зрения того, как нужно использовать исходные принципы для решения конкретных проблем.

Подход, основанный на принципах, несмотря на свою широкую известность и огромную роль, которую он сыграл в развитии биоэтики, подвергся серьезной критике со стороны представителей академической науки. Среди множества критических замечаний можно назвать следующие.

1. Во-первых, это проблема того, как конкретно применять принципы к практическим ситуациям, поскольку совсем неочевидно, что мы получим однозначное решение данной проблемы, исходя из какого-то базового набора принципов или правил. Это можно назвать проблемой «построения моста между принципами и ситуациями».

2. Во-вторых, это проблема конфликта принципов, поскольку возможны практические ситуации, когда уже сами исходные принципы противоречат друг другу.

Подход, основанный на случаях

Другой подход, который стремится преодолеть недостатки первого, — это подход, основанный на случаях. Он в некотором смысле движется в обратном направлении — он не идет от теоретических принципов к реальным ситуациям, а разбирает конкретные случаи из практики, чтобы на основе их анализа выработать какие-то правила или хотя бы ориентиры для других похожих ситуаций.

Этот подход выглядит привлекательно, особенно для практических медиков, поскольку меньше связан с абстрактными моральными рассуждениями, а рождается непосредственно из конкретных примеров и случаев из практики.

Специалисты по биоэтике приложили много усилий, для того чтобы создать специальные методы истолкования случаев для решения биоэтических проблем. Так, известность получила группа методов под названием «казуистика» — под влиянием основополагающей работы Стива Тулмина и Альберта Джонсена «Злоупотребление казуистикой» (1988).

В этой работе, в частности, говорится о том, что решение моральных проблем всегда связано с пониманием конкретных обстоятельств и содержательной стороны дела. Иными словами, решение моральной проблемы совсем не похоже на логический вывод из какого-то абстрактного принципа. Казуистика основывается на разборе значимых случаев из практики (моральных прецедентов) и процедурах мышления по аналогии; при этом основой для решения данной моральной проблемы выступает получившая признанное решение ситуация в прошлом (парадигма). Основные этапы применения казуистического метода показаны на рис. 1.3.

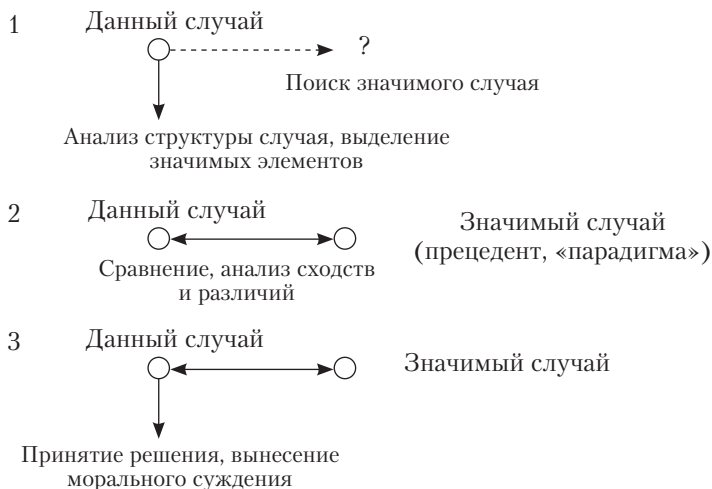


Рис. 1.3. Общая схема казуистического метода в биоэтике:

1—3 — этапы анализа

Методы казуистики развивают также Дж. Толлмон, Р. Миллер и другие авторы.

В целом, к недостаткам подхода, основанного на случаях, можно отнести следующие.

1. С развитием этого подхода приемы исследования и интерпретации случаев сами по себе становятся все сложнее, поэтому оказывается затруднительным применять их для решения практических задач.

2. Далеко не всегда можно найти прямой путь в виде аналогии между прецедентом и данной ситуацией, в связи с чем анализ прецедента может не привести к однозначному решению.

3. Наконец, для нахождения обоснованных решений все равно требуются аргументы в виде указания на какие-то ясные моральные идеи и правила; поэтому проблема исходных теоретических оснований и построения «мостов» между принципами и ситуациями все равно остается.

Развитие методологии биоэтики показывает, что между рассмотренными двумя подходами нет непроходимой пропасти; на современном этапе прилагается много усилий к тому, чтобы наладить плодотворное взаимодействие между ними, построить тесные связи между областями теоретических принципов и практических ситуаций.

Рассмотрим теперь некоторые важнейшие этические концепции, которые применяются для анализа и решения моральных проблем медицины, а также некоторые альтернативные подходы, которые выражают стремление найти новый взгляд на биоэтику и проблему ее теоретических оснований.

Утилитаризм

Концепция утилитаризма в биоэтике была и остается одной из самых влиятельных, несмотря на серьезную критику и обилие альтернативных подходов.

Основополагающий вклад в развитие утилитаризма внес английский философ и правовед Иеремия Бентам (1748—1832), который, в свою очередь, базировался на идеях ряда авторов, таких как Д. Юм, К. А. Гельвеций и другие. Главное произведение Бентама — «Введение в основание нравственности и законодательства» (1789).

Бентам сформулировал понятие утилитаризма (от лат. *utilitas* — польза, выгода), которое легло в основу его концепции. Под этим понималось некое благо, или счастье, польза. Бентам полагал, что каждый индивид своей деятельностью стремится увеличить сумму своего счастья и уменьшить страдания. Представление о том, что люди в своих действиях стремятся к счастью (удовольствию, наслаждению и т.п.), имело давнюю традицию в философии. Однако одна из важнейших идей Бентама состояла в том, что эту полезность можно представлять как нечто исчислимое, некое количество, которое может увеличиваться (или уменьшаться) в зависимости от наших действий.

Так возникает идея моральной арифметики, а также исчисления счастья. Бентам даже пытался разработать процедуры, которые могли бы сводить удовольствия разных людей к некоей однородной величине (несмотря на то что полезности, или удовольствия, для разных индивидов, конечно, имеют разные смыслы).

Основной принцип этики утилитаризма — наибольшее счастье для наибольшего количества людей. Бентам не сам изобрел его, однако он ясно его сформулировал и сделал отправной точкой обширной теоретической системы.

Этот принцип имел очень широкие приложения в учении Бентама. Помимо моральной философии, Бентам применил его также для анализа работы общественных институтов, законов и законодательных реформ, а также в экономической сфере. Позже известный английский ученый и философ Дж. Ст. Милль в работе «Утилитаризм», написанной в 1863 г., систематизировал и развил взгляды Бентама, а также способствовал распространению самого понятия «утилитаризм».

Сущность этики утилитаризма состоит в оценке моральности того или иного решения или действия по его *последствиям* или результатам. Критерий правильного действия, согласно утилитаризму: *действовать нужно так, чтобы максимизировать полезность для максимального числа людей.*

Морально оправданное действие — то, которое в данной ситуации добивается *наилучшего прироста полезности* среди всех возможных альтернатив.

Еще один вариант формулировки утилитаристского критерия, связанный с ситуацией, когда действие приносит не только положительные, но и отрицательные следствия: морально оправданное действие — то, которое добивается *наилучшего достижимого соотношения полезных и негативных результатов.*

Развитие этики утилитаризма породило массу разновидностей, различающихся в зависимости от того, как конкретно применять основной принцип, оценивать количество полезности и т.п.

Например, среди множества прочих выделяют такие версии, как утилитаризм правил и утилитаризм действий.

Согласно *утилитаризму правил*, индивид в своих действиях должен следовать хорошо обоснованным правилам (не обманывай, не нарушай обещаний и т.п.), которые, в свою очередь, базируются на принципе полезности. Это связано с тем, что морально обоснованные правила с высокой вероятностью и в подавляющем большинстве ситуаций максимизируют общее благо, т.е. следование таким правилам является оптимальной стратегией.

С точки зрения *утилитаризма действий*, выбор конкретного решения зависит от особенностей конкретной ситуации; мы должны действовать так, чтобы достичь наибольшей полезности в данной ситуации (и при этом могут быть морально оправданы исключения из хорошо обоснованных правил).

Одна из причин популярности утилитаризма в биоэтике — это возможность разнообразного истолкования понятия «полезность». В частности, в медицине и здравоохранении под этим понятием можно понимать, например, такие блага, как здоровье, положительный исход лечения, удовлетворенность пациента, снижение заболеваемости населения, повышение продолжительности жизни и многое другое; отсюда проистекает его широкая применимость к проблемам биомедицинской этики.

Отметим также, что утилитаризм оказал огромное влияние на последующее развитие экономической науки: ведь полезность можно понимать также и как экономическую выгоду, прибыль, т.е. в экономическом смысле. Многие экономические идеи Бентама нашли позже своих последователей и породили целые направления экономической мысли. Сходство утилитаристской этики с экономическим мышлением является одной ее из самых характерных черт: в ряде случаев применение методов этики утилитаризма выглядит как своеобразное подобие экономических расчетов, в том числе при решении тех или иных задач биомедицинской этики.

В целом утилитаристский подход в биоэтике лучше всего проявляет себя в тех ситуациях, когда возможно приблизиться к некоторому обоснованному решению с помощью уточненных оценок или расчетов. Например, это могут быть задачи по размещению медицинских ресурсов, оценке предпочтений пациента и др. В этих случаях стремление утилитаристской этики к измеримости и точности оказывается явным достоинством.

Однако в адрес утилитаризма высказано много критики. Поскольку он занимается только результатами, но при этом отвлекается от мотивов, обязанностей, моральных ценностей, то он не может оценить внутреннюю мораль того или иного действия, поступка. Между тем оценка внутренней стороны человеческих действий тоже крайне важна для анализа и решения моральных проблем.

Кроме того, для многих морально усложненных ситуаций и проблем подсчет полезности может оказаться невозможным, либо бессмысленным или вообще поведет нас по упрощенному и ложному пути.

Деонтологическая этика

В противоположность утилитаризму, **деонтологическая этика** (от греч. *deontos* — нужное, должное) рассматривает *внутреннюю* сторону человеческих поступков.

Деонтологическая этика восходит к *этике долга*, разработанной великим немецким философом И. Кантом (1724—1804). Согласно Канту, человек поступает морально тогда, когда следует своему долгу.

Кант приводит в своих работах несколько определений главного этического критерия (так называемого категорического императива), позволяющего оценить, насколько морально то или иное действие. Одна из наиболее популярных и прозрачных формулировок категорического императива состоит в следующем: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству». Категорический императив Канта — это критерий оценки, нравственно ли то или иное действие *вообще*, само по себе (а не потому, что оно приносит некую пользу).

Система этических представлений, идущая от Канта, оказала большое влияние на биоэтику, прежде всего на этику научных исследований (где особенно ярко видно, что испытуемый должен быть максимально защищен от эксплуатации в качестве средства), а также на разработку различных кодексов, где речь идет о нравственных обязательствах врачей и других медицинских работников. Вместе с тем, система Канта в подлинном виде очень сложна, что затрудняет использование ее для практических нужд биоэтики.

Хотя деонтологические теории часто связывают с этикой Канта, и иногда даже их всех называют кантианскими, понятие деонтологической этики все же шире. Общим признаком деонтологических теорий является то, что они защищают самооценность, внутреннюю значимость определенных поступков и действий. Различные версии деонтологического подхода могут принимать во внимание и последствия наших действий, однако все равно они настаивают на том, что внешними средствами (например, измерением полезности) нельзя оценивать или обосновывать то, что имеет ценность в себе. В этом они противостоят утилитаризму.

Однако у всех деонтологических теорий имеется одна общая проблема: как обосновать самооценность тех или иных принципов, требований, обязательств. Иными словами, должна быть опора на какой-то безусловный моральный авторитет или какие-то несомненные истины. В качестве такой опоры представители деонтологического подхода могут опираться на религиозную традицию (это характерно для религиозных концепций биоэтики), какие-либо традиционные ценности, общепризнанные представления и др. Кстати, у самого Канта, который стремился построить светскую чисто рациональную этическую систему, была сконструирована очень сложная система доказательств того, что его категорический императив является безусловным источником подлинной морали.

Достоинством деонтологического подхода в целом является то, что он отвергает различные внешние соображения как этически значимые (например, соображения выгоды, пользы) и стремится прояснить и защитить самооценный моральный смысл определенных отношений, обязательств и действий. Это очень важно для медицины, поскольку она с самого начала развивалась как деятельность, наполненная высоким моральным смыслом. Например, сторонники деонтологической этики, как правило, решительно противостоят коммерциализации медицины.

Этот подход также вносит вклад в прояснение сложных проблем инновационных биомедицинских разработок. Так, сторонники этого подхода отвергают исследования на эмбрионах, выращивание эмбрионов в промышленных целях, клонирование человека и тому подобные действия как недопустимые с нравственной точки зрения.

Трудности деонтологической этики тоже многочисленны. Так, в условиях морального плюрализма и релятивизма, характерных для современного общества, довольно трудно обосновать, что тот или иной принцип или решение проблемы имеет универсальное значение и что с этим должны согласиться представители самых разных систем взглядов.

Поскольку деонтологическая этика, в отличие от утилитаризма, акцентируется не на результатах, а на внутреннем смысле поступков, то в такой этической системе может быть морально оправдано действие из благих намерений, которые вызвало отрицательные последствия (что может противоречить здравому смыслу).

Кроме того, критики указывают, что деонтологический подход во многих ситуациях оказывается слишком абстрактным и не может преодолеть реальные противоречия и ценностные конфликты, столь частые для сложных проблем современной медицинской науки и практики.

Этика добродетелей

Еще одно направление в современной биоэтике получило название «этика добродетелей» (англ. *virtue ethics*), или «аретический подход» (от греч. *arete* — добродетель, совершенство). Сторонники этики добродетелей стремятся найти свой путь в биоэтике, преодолевающий трудности утилитаризма и деонтологической этики. Корни этики добродетелей уходят в античную философию — к Платону и особенно Аристотелю, его знаменитой «Никомаховой этике», где изложены основы аристотелевской теории добродетелей.

Возрождение этой традиции в моральной философии началось во второй половине XX в. и было связано с именами таких зарубежных исследователей, как Г. Э. Энскомб, А. Макинтайр, М. Слоут, Р. Херстхаус и другие.

Под добродетелями понимают некие положительно расцениваемые качества личности, устойчивые черты характера. Таким образом, аретический подход больше направлен не на конкретные поступки, а на самого человека — субъекта, выполняющего те или иные действия. Тем самым аретический подход стремится преодолеть слишком абстрактный подход к этике, характерный для утилитаризма и деонтологизма, и поместить в центр внимания не отвлеченные правила действий, а конкретные качества личности, на которых базируется ее деятельность.

С точки зрения теории добродетелей, морально правильное действие — то, которое основано на положительных моральных качествах (добродетелях) индивида. Например, для врачебной практики на первый план выходят такие добродетели, как ответственность, добросовестность, сострадание, требовательность к себе и другим, старательность и т.п. Поэтому теория добродетелей находит удачное применение в тех разделах биомеди-

цинской этики, которые посвящены профессиональной этике медицинских работников. Теория добродетелей также вносит вклад в прояснение задач медицинского образования — для повышения морального уровня медицинской профессии, согласно этой теории, необходимо прежде всего воспитывать необходимые личностные качества медицинских специалистов.

Этика добродетелей, разумеется, не отказывается от моральных принципов и правил; просто она придает большее значение самому человеку. Она утверждает, что полностью поведение человека невозможно отрегулировать принципами и правилами (особенно если это ситуации уникальные, непредвиденные и т.п.). Поэтому решающее значение имеет вопрос, каким должен быть сам индивид, какими качествами он должен обладать, чтобы действовать этически правильно.

Вместе с тем этика добродетелей тоже может использовать принципы и правила (как утилитаризм и деонтологизм), разрабатывать руководства к действию, но при этом они становятся производными от необходимых качеств добродетельной личности. С этой точки зрения правильное действие то, которое совершил бы добродетельный индивид в данных обстоятельствах; из этого принципа могут быть выведены, например, правила вида «поступи наиболее честным образом», «веди себя принципиально по отношению к коллегам» и т.п.

Теория добродетелей активно развивается, ее сторонники стремятся сделать ее полноценной альтернативой широко признанному утилитаризму и деонтологизму. Помимо приложений, в профессиональной этике медицинских работников имеются попытки применения теории добродетелей к решению наиболее острых биоэтических проблем (таких как аборт, эвтаназия и др.) исходя из предполагаемой системы действий добродетельного человека.

Как и другие этические теории, аретический подход имеет немало трудностей, среди которых можно назвать следующие. Наличие добродетелей само по себе не является гарантией надлежащего поведения: хороший человек может, тем не менее, ошибаться или выполнять действия с отрицательными последствиями. Этика добродетелей пока не предложила четкие и обоснованные критерии оценки правильных действий. Для решения сложных многоаспектных проблем полезнее могут оказаться более объективные и абстрактные подходы, чем подход с точки зрения положительных человеческих качеств — добродетелей.

Феминистская этика

Феминистское направление в биомедицинской этике направлено, прежде всего, против неравенства по половому признаку. Как считают сторонники этого подхода, половая дискриминация глубоко проникла в современные системы ценностей, культурные представления и социальные отношения. В том числе эта дискриминация имеет множество проявлений в медицинской науке и практике.

Феминистская биоэтика пока не имеет таких широких приложений, как предыдущие подходы. Скорее, ее следует рассматривать как критику сложившегося положения дел в системе медицинской помощи и в обще-

стве в целом. Она стремится дополнить, сбалансировать доминирующие так называемые мужские системы ценностей, осознать проблемы, которые не получили своего выражения в этих системах взглядов.

В частности, феминистский подход уделяет много внимания проблеме здоровья женщины, ее положению в системе здравоохранения, а также этическим проблемам репродуктивных технологий (причем репродуктивные технологии часто рассматриваются здесь как инструменты мужского контроля над женским организмом).

Кроме того, для феминистской биоэтики характерен некий сугубо «женский» взгляд на медицинскую практику как на деятельность, которая должна основываться на ценностях заботы, сострадания и сочувствия, а не на целях технического биомедицинского контроля.

Этика заботы

Этика заботы (англ. *ethics of care*) — относительно новое направление в современной этике, и биомедицинской этике в частности. Оно во многом родственно феминистским течениям. Одновременно оно сходно и с этикой добродетелей, поскольку заботу саму по себе можно рассматривать как некую базисную добродетель.

Этика заботы стремится прояснить определенный тип морального поведения, который был утрачен или не раскрыт в других этических концепциях. Этика заботы выводит на первый план не единичного субъекта действий, а взаимоотношения субъекта с другими. Таким образом, здесь присутствует не индивидуализм, а взаимосвязь с окружающими, контекст отношений; не противопоставление, а солидарность и забота о других.

Для биомедицинской этики концепция заботы особенно полезна для прояснения морального смысла ежедневной медицинской практики, в том числе для сестринского дела, поскольку этика заботы позволяет подчеркнуть специфику моральных оснований этой профессии.

В целом, общее теоретическое поле биоэтики продолжает развиваться. Несмотря на то что единой системы взглядов на проблемы биоэтики не выработано, с дальнейшей разработкой этических подходов все более отчетливо проявляется их конструктивное взаимодействие и взаимодополнение, в том числе на фоне их взаимной критики.

Уровни этического анализа

Когда речь идет о выборе способа действия (или оценке уже совершенного действия), то возникает потребность в моральном обосновании. В большинстве случаев мы действуем не задумываясь, согласно очевидным моральным нормам. Но при столкновении с более сложными задачами появляется необходимость в более детальном и аргументированном этическом анализе. Бичамп и Чилдрес в своих «Принципах биомедицинской этики» предлагают следующую условную структуру морального рассуждения (рис. 1.4).